

지방간(MASLD), 단순히 "살찐 간"이 아니라 대사질환입니다

MASLD(대사이상 지방간질환) — 당뇨·고혈압·이상지질혈증과 한 묶음인 대사 문제입니다.
가장 위험한 건 간이 아니라 심장이고, 예후를 정하는 건 지방의 양이 아니라 **흉터(섬유화)**
단계입니다. 그리고 되돌릴 수 있습니다.

이름이 바뀐 이유 — 지방간은 '대사질환'입니다

2023년 국제 합의로 '비알코올성 지방간'이 '대사이상 지방간질환(MASLD)'으로 바뀌었습니다

▲ 낙인을 없애려고

'알코올 아님'·'지방'이라는 말이 주는 **낙인**을 없애기 위해서입니다.

🚩 본질이 대사 문제라서

다른 원인을 빼고 남는 병이 아니라, **대사 문제가 본질**이라는 점을 이름에 담았습니다. 병 자체는 거의 같아 기존 환자 대부분이 그대로 해당됩니다.

🧠 '살찐 간'이 아니라 대사질환

당뇨·고혈압·이상지질혈증과 **같은 뿌리**에서 나오는 한 묶음의 문제입니다.

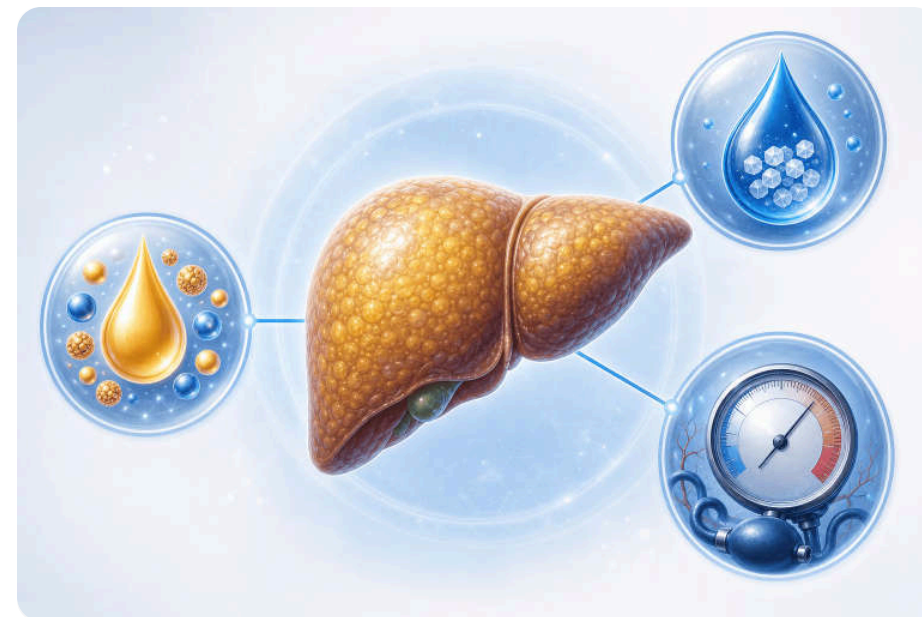


그림 · 지방간(가운데)은 기름(지질)·당(혈당)·혈압 문제와 이어진 한 묶음입니다(설명용 그림).

Tip · 지방간을 진단받았다면 혈당·혈압·콜레스테롤도 함께 확인하세요.

근거 · 2023 국제 명명 합의 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

얼마나 흔하고, 어떻게 진단하나요

간에 지방이 있고 대사 위험 인자가 한 가지만 있어도 진단됩니다 — 그래서 문턱이 낮습니다

31%

한국 성인 유병률

약 3명 중 1명 — 흔한 대사질환

2/3

당뇨 환자에서 동반

당뇨가 있으면 동반 비율이 더 높습니다

1개

위험 인자만 있어도

간 지방 + 대사 위험 인자 1개면 진단



한국 진단 기준

간에 지방이 있으면서 **대사 위험 인자** 중 하나라도 있으면 대사이상 지방간질환입니다.



대사 위험 인자

체질량지수 23 이상, 허리둘레 남 90cm·여 85cm 이상, 혈당·혈압·중성지방·좋은 콜레스테롤(HDL) 이상.

Tip · 기준이 낮아 생각보다 많은 분이 해당됩니다.

근거 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

가장 위험한 것은 간이 아니라 심장입니다

지방간이 있는 분의 사망 원인 1위는 심혈관질환입니다 — 지방간 진단은 '심장 경고등'입니다

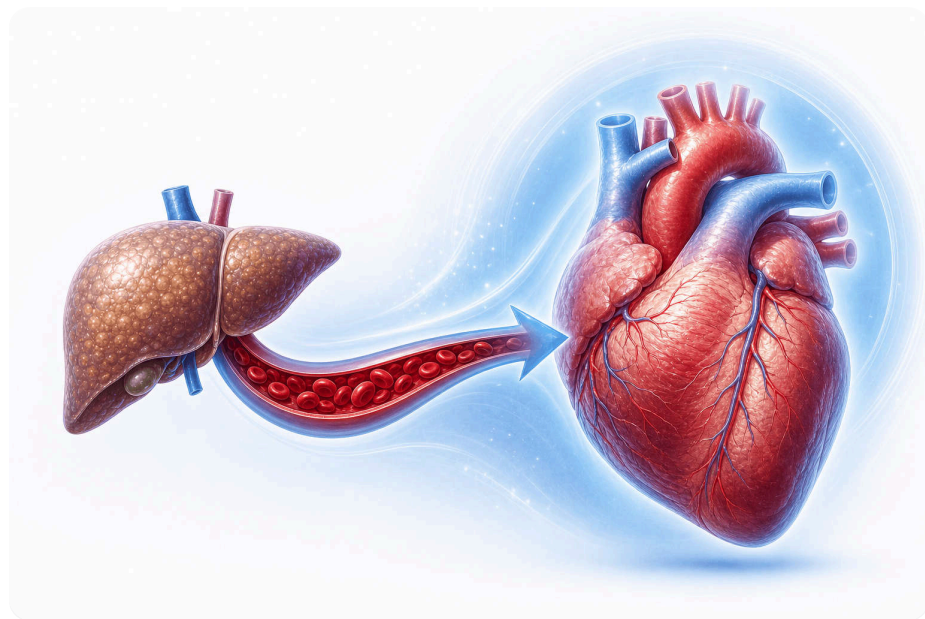


그림 · 지방간(왼쪽)의 위험은 혈관을 따라 심장(오른쪽)으로 이어집니다 (설명용 그림).

사망 원인 순서

심혈관질환 → 간 밖의 암 → 간 질환 순서입니다.

심장·혈관에 빨간불

지방간을 진단받았다면 간 자체보다 **혈압·혈당·콜레스테롤·체중**을 먼저 챙겨야 합니다.

필요하면 약으로도

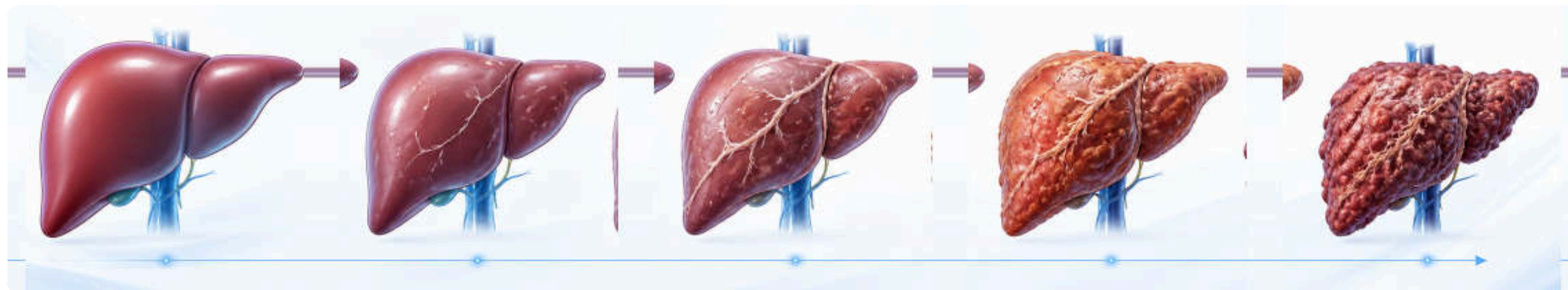
필요하면 스타틴 같은 약으로 콜레스테롤을 적극적으로 관리합니다.

Tip · 1순위로 관리할 것 — 혈압·혈당·콜레스테롤·체중.

근거 · EASL·EASD·EASO 2024 지침 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

앞날을 정하는 것은 '흉터(섬유화)' 단계입니다

지방의 양이나 염증보다, 간이 얼마나 굳었는지(F0~F4)가 수명을 좌우합니다


F0

흉터 없음
정상

F1

가벼운 흉터

F2

중간 흉터

F3

진행한 흉터
위험 증가

F4

간경변
위험 급증

핵심 F4(간경변)는 F0에 비해 사망 위험이 **6~10배 이상** 높고, **F3~F4부터 위험이 급증** 합니다. 그래서 '지방이 얼마나 끼었나'보다 '**흉터가 몇 단계인가**'를 확인하는 것이 더 중요합니다.

Tip · 그림은 왼쪽 정상 간(F0)에서 오른쪽 간경변(F4)까지 흉터가 늘어나는 모습입니다(설명용 그림).

근거 · AASLD 2023 진료지침 · EASL·EASD·EASO 2024 지침

흉터 검사는 간단한 2단계입니다

먼저 피검사로 위험을 거르고, 필요하면 간의 굳기를 재는 초음파를 합니다

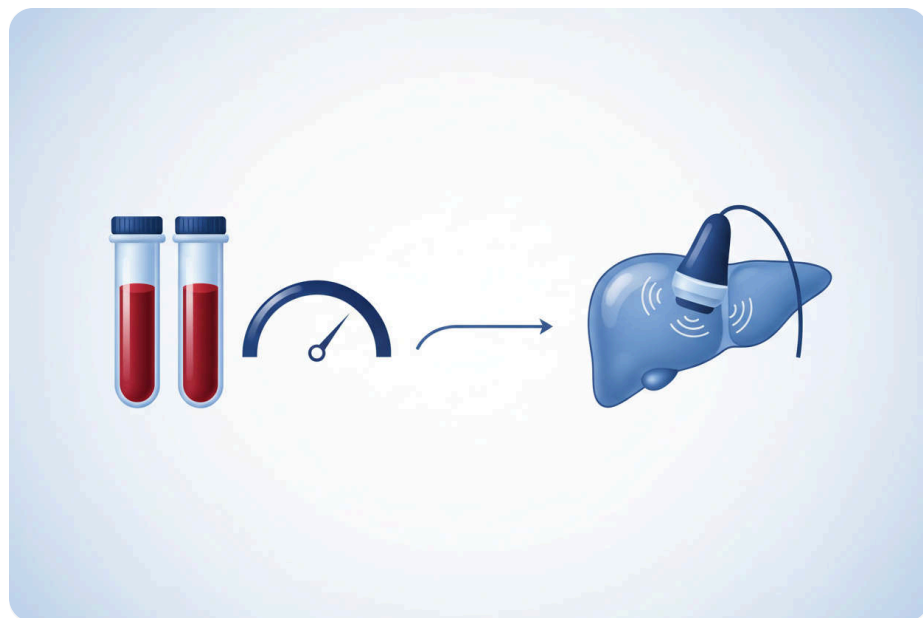


그림 · 피검사(왼쪽)로 먼저 거르고, 필요하면 초음파로 간의 굳기를 잽니다(설명용 그림).

1 피검사 점수(FIB-4) 1단계

나이·간수치·혈소판 등 일반 혈액검사 수치로 계산해 비용이 거의 들지 않습니다. 낮으면 안심, 애매하거나 높으면 2단계로.

2 탄성 초음파(파이버로스캔 등) 2단계

간이 얼마나 굳었는지를 잽니다. 대략 9킬로파스칼(kPa) 미만이면 안심권, 그 이상이면 추가 검사·전문의 상담.

다시 잽 때는

같은 기기로, 검사 전 **4시간 공복**으로 잽니다.

Tip · 다시 잽 때 같은 기기를 써야 수치를 바르게 비교할 수 있습니다.

근거 · 대한간학회 2025 진료가이드라인 · EASL·EASD·EASO 2024 지침

되돌릴 수 있습니다 — 생활습관이 첫 번째 치료

체중을 7~10% 빼고 식사·운동을 바꾸면 지방간염과 흉터가 좋아질 수 있습니다



① 체중 7~10% 감량

가장 중요합니다. 10% 이상 빼면 지방간염이 사라지는 경우가 약 90%, 흉터가 좋아지는 경우가 약 45%입니다.



② 지중해식 식사

올리브유·채소·생선·통곡물 위주로. 당·단 음료·초가공식품·과당은 끊습니다. 단 음료를 주 4회 넘게 마시면 위험이 약 45% 올라갑니다.



③ 주 150분 운동 + 커피

중간 강도 유산소 주 150분(+근력)이면 체중이 안 빠져도 간 지방이 30%가량 줄 수 있습니다. 금기가 없다면 커피 하루 3잔 이상도 도움과 연관됩니다.



④ 술 줄이기 — 흉터가 있으면 끊기

술은 줄이는 것이 기본이고, 흉터가 진행했거나 간경변이면 완전히 끊어야 합니다. 술은 흉터를 빨리 진행시킵니다.

Tip · 한 번에 다 바꾸기보다 한 가지씩 꾸준히 하는 것이 오래갑니다.

근거 · EASL·EASD·EASO 2024 지침 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

마시는 술의 양에 따라 이름이 달라집니다

술을 얼마나 마시는지에 따라 분류가 갈리므로, 정확히 말씀해 주시는 것이 중요합니다

대사이상 지방간질환(MASLD)

대사 문제가 주된 원인인 지방간입니다.

- 음주량이 기준보다 적은 범위
- 치료의 중심은 체중 감량·대사 조절
- 그래도 술은 줄일수록 간에 좋습니다

VS

대사·알코올 복합 지방간(MetALD)

대사 문제에 술의 영향이 함께 작용합니다.

- 남성 하루 30g(소주 약 반 병)·여성 20g을 넘는 경우
- 이 구간부터 술의 영향이 커집니다
- 정확한 음주량이 분류와 치료를 정합니다

Tip · 진료 때 한 주에 마시는 술의 종류와 양을 그대로 말씀해 주세요.

근거 · 2023 국제 명명 합의 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

약은 있나요?

미국에서는 2종이 승인됐지만 국내는 아직 ‘지방간염 전용 약’이 허가 전입니다 — 중심은 여전히 체중·대사 관리

구분	대상	설명
미국 승인 — 먹는 약(레스메티론)	흉터 2~3단계 (간경변 아님)	지방간염에 쓰는 먹는 약으로 미국에서 승인됐습니다. 간경변은 허가 대상이 아닙니다
미국 승인 — 주사약(세마글루티드 2.4mg)	흉터 2~3단계 (간경변 아님)	GLP-1 계열 주사약으로 미국에서 승인됐습니다. 역시 간경변은 허가 대상이 아닙니다
국내 현황	허가 전	‘지방간염 전용 약’은 아직 없습니다. 비만·당뇨가 있으면 그 목적으로 GLP-1 주사 등을 써서 체중을 줄여 간을 간접적으로 치료합니다

Tip · 두 약의 미국 지방간염 치료 허가 대상은 간경변이 없는 흉터 2~3단계입니다.

근거 · 미국 식품의약국(FDA) 허가 사항 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

간암 검진은 '간경변'부터 시작합니다

흉터 단계에 따라 검진 방법이 달라집니다 — 흉터가 가벼우면 피검사로 위험만 거릅니다

1

흉터가 가벼우면

선별

모두에게 하는 간암 검진은 필요하지 않습니다. 대신
피검사 점수(FIB-4)로 위험을 거릅니다.

2

간경변(간경화)이면

6개월마다

초음파 + 혈액검사(알파태아단백, AFP)를
정기적으로 받습니다. 국가암검진 무료 대상입니다.

3

체격이 큰 경우

보완

초음파로 잘 안 보일 수 있어, 필요하면 CT나
MRI로 보완합니다.

검진 날짜를 놓치지 마세요 간경변이 있으면 증상이 없어도 6개월마다 초음파와 혈액검사를 받습니다.

Tip · 내 흉터 단계를 알아야 검진 간격이 정해집니다.

근거 · 대한간학회 2025 진료가이드라인 · 국가암검진 지침

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

지방간을 바르게 이해하고 관리하기 위한 핵심 정리

01 지방간은 '살찐 간'이 아니라 대사질환입니다

02 가장 위험한 것은 간이 아니라 심장(심혈관)입니다

03 앞날을 정하는 것은 흉터(섬유화) 단계 F0~F4입니다

04 검사는 피검사 점수 → 탄성 초음파의 2단계

05 체중 7~10% 감량이 첫 번째 치료입니다

06 지중해식·주 150분 운동·커피·절주로 되돌릴 수 있습니다

07 국내 전용 약은 허가 전 — 중심은 체중·대사 관리

08 간경변이면 6개월마다 간암 검진을 받습니다

Tip · 궁금한 점은 진료 때 언제든지 물어보세요.

근거 · 대한간학회 2025 진료가이드라인 · EASL-EASD-EASO 2024 지침 · AASLD 2023

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

지방간을 진단받은 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 검사와 치료는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

대한간학회 2025 대사이상 지방간질환 진료가이드라인 · EASL·EASD·EASO MASLD 진료지침 2024 ·

AASLD 2023 진료지침 · 2023 국제 명명 합의 · 미국 식품의약국(FDA) 허가 사항 · 국가암검진 지침



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요